Cabinet de dermatologie Es-Senia

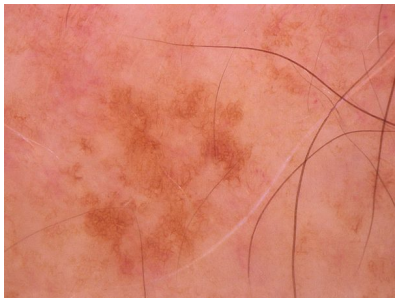
تقرير المساعدة على الفرز — آفة جلدية

dermIA الإصدار 2.0.0 · النموذج ham10000-bcn20000-m5-v3 الإصدار 3.0.0 (الملف: كامل)

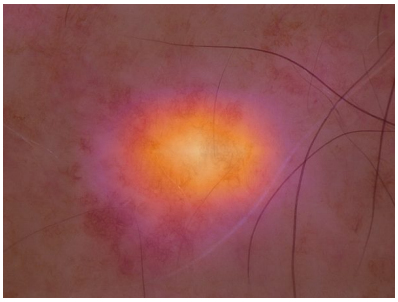
المريض	P-2026-0430	تاريخ التحليل	21:32 31/10/2026
العمر (بالسنوات)	60	طلب التحليل	Dr Karim Haddad
الجنس	ذكر	الموضع	الطرف العلوي
الآفة المتابعة	رقم 1	عتبات القرار	الأصلية

حميد على الأرجح

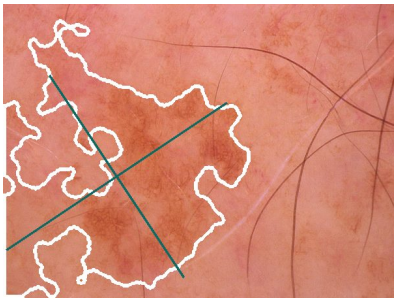
تقرن حميد مرجح
آفة حميدة على الأرجح. المتابعة حسب التقدير السريري، وأي تغير في الآفة يستدعي فحصا جديدا.



الصورة المحللة



المناطق الأكثر تأثيرا (Grad-CAM، «تقرن حميد»)



الحدود والمحاور المستخدمة في معايير ABCD

الاحتمالات المقدرة

التشخيص	الاحتمال	ضمن المجموعة المضمونة*
تقرن حميد	97,0%	نعم
وحمة ميلانينية	2,9%	
ورم ميلانيني	0,1%	
ورم ليفي جلدي	0,0%	
تقرن سفعي / داء بوين	0,0%	
آفة وعائية	0,0%	
سرطانة الخلايا القاعدية	0,0%	

* المجموعة المطابقة (طريقة موندريان، ألفا = 0,10): تحتوي على التشخيص الصحيح باحتمال لا يقل عن 90% لكل فئة، بافتراض أن الحالات تشبه بيانات المعايرة. يتخذ قرار الورم الميلانيني إذا كان p(mel) ≥ 0,03 (نسبة التكلفة R = 10).
عتبات النموذج الأصلية، معايرة على مجموعة المعايرة الخاصة به.

معايير ABCD الآلية (استرشادية)

المعيار	القياس	التفاصيل
A — عدم التناظر	2/2	محاور رئيسية غير متناظرة (الشكل أو الألوان)
B — الحواف	7/8	قطاعات ذات حافة حادة
C — الألوان	2/6	بني فاتح، أزرق رمادي
D — القطر	11,6 مم	أكثر من 6 مم

تنبيه: تلامس الآفة حافة الصورة: المعايير A وB وD أقل موثوقية.
قياسات آلية استرشادية: على مجموعة الاختبار من HAM10000 لا يميز كل منها بين الورم الميلانيني والوحمة إلا بشكل محدود (AUC من 0,66 إلى 0,73). وهي لا تغني عن الفحص بالمنظار الجلدي.

المراجعة الطبية

لم يراجعها طبيب بعد.

توقيع الطبيب: _____

تنبيه. أعدت هذه الوثيقة بواسطة أداة للمساعدة على اتخاذ القرار، وهي لا تعد تشخيصا ولا تغني عن الفحص السريري ولا عن الفحص النسيجي. حالة النموذج: بحث — استخدام غير تجاري — ليس جهازا طبيا. بيانات التدريب: BCN20000 + HAM10000 (Tschandl et al., Sci Data 2018, doi:10.1038/sdata.2018.161) (Hernández-Pérez et al., Sci Data 2024, doi:10.1038/s41597-024-03387-w) — الترخيص CC BY-NC 4.0 (غير تجاري).